11. IL CUORE : RIASSUNTO E IMPLICAZIONE PRATICA

DURATA : 11:02 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'importanza del cuore nello sviluppo embrionale, posizionandolo come il punto d'incontro delle forze vitali tra lo spermatozoo e l'ovulo. Si apprende come il cuore si forma all'interno della linea primitiva, interagendo con strutture chiave come il tubo neurale e il mesoderma. Vengono anche affrontati i concetti di diastole e sistole, con particolare attenzione a come questi movimenti possono essere osservati e integrati nella pratica osteopatica. I praticanti impareranno a utilizzare i fulcri embrionali per rivitalizzare ed equilibrare i sistemi cardiaco e cerebrale, affinando il loro approccio attraverso punti di appoggio pertinenti.

IL CUORE: RIEPILOGO E IMPLICAZIONI PRATICHE

IL CUORE: PUNTO DI INCONTRO SIMBOLICO

Il **cuore** è considerato il punto di incontro simbolico tra lo **spermatozoo** e l'**ovulo**. È qui che si stabilisce un **pattern fondamentale**, manifestandosi anche su un piano di polarità.



FIG. — Embrione bicellulare

APPARIZIONE E SVILUPPO PRECOCE

L'emergere del cuore è particolarmente interessante a livello della **linea primitiva**.

È il vestigio sotto S2, estremità terminale della **notocorda** e luogo della sensazione.

Lo affrontiamo nel suo ambiente facciale e nel suo movimento di sviluppo. Si re-integrerà nella **neurulazione secondaria** durante la chiusura e la formazione del piccolo bacino.

La neurulazione secondaria è quello spazio tra il **filum terminale** e il **germoglio caudale**, che implica una crescita differenziale del **tubo neurale** rispetto all'**endoderma** anteriore, con un'apertura del lume.

L'endoderma anteriore è l'endoderma embrionale, ma qui, a livello **mesoblastico** e anche a livello del cuore.

In quest'onda con la linea primitiva, che termina in S2, una **forza cardiaca primitiva** è già presente. La localizzazione presunta nell'epiblasto fa parte del potenziale del cuore, è la localizzazione più precoce identificata.

Le **cellule cardiogeniche** si trovano a livello dell'epiblasto, nello strato presuntivo dell'epiblasto, ancor prima della formazione del mesoderma.

Ritroveremo questa lamina presuntiva. Un movimento di crescita è seguito da una congestione, poi dall'integrazione e dall'incontro dei due tubi, organizzata dalla periferia dalla **cavità amniotica**. Il tubo neurale, il tubo cardiaco e l'integrazione del diaframma concorrono alla formazione del cuore.

Questo avviene contemporaneamente alla chiusura del tubo neurale e all'integrazione del **celoma** esterno nel celoma interno.

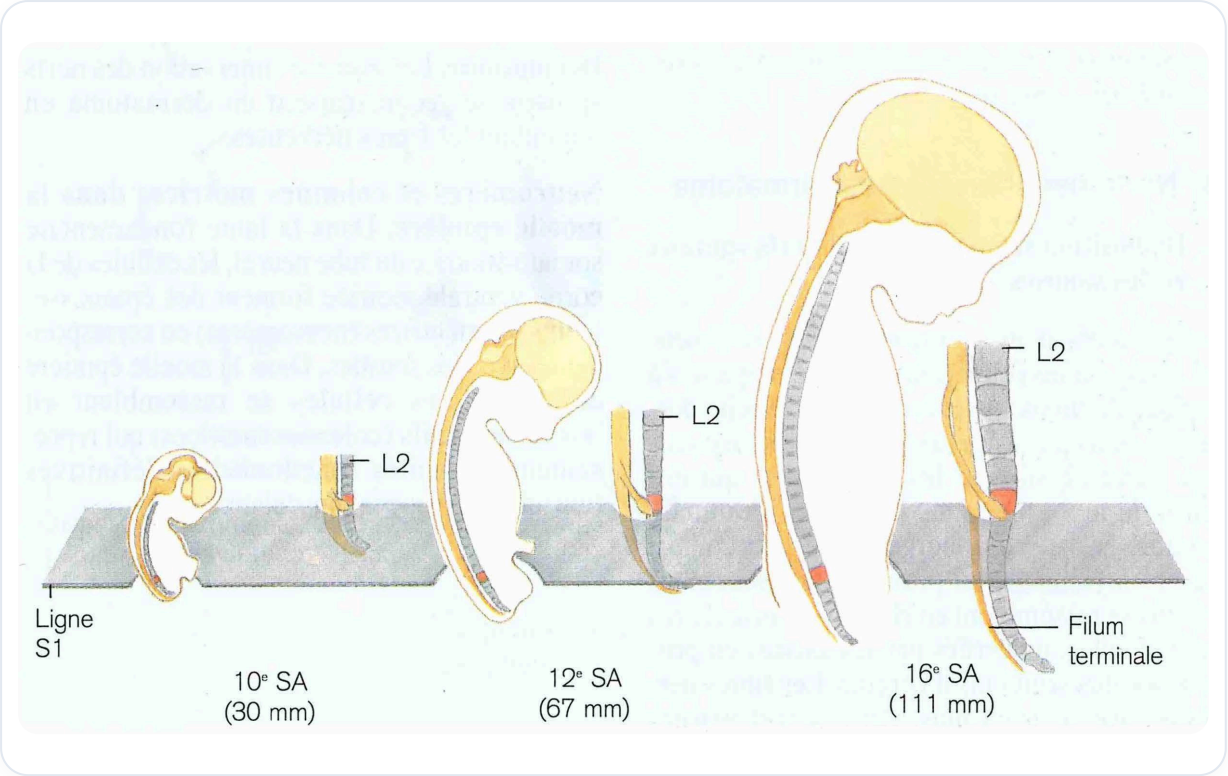


FIG. — Crescita relativa midollo spinale

LA LINEA PRIMITIVA E IL FULCRO CARDIACO

Il luogo più precoce identificabile è la linea primitiva.

La notocorda termina a livello di S2. Lo spazio tra S2 e l'estremità della linea primitiva contiene il vestigio della linea primitiva.

Il **fulcro embrionale** del cuore è sul coccige.

Il cuore si pone quindi in una postura piuttosto **diastolica**, cercando energia e volume. Scende nel suo movimento.

Il cuore presenta anche un fulcro, cioè un punto di origine, che può manifestare in modo diverso.

MOVIMENTI E STRUTTURE CARDIACHE

Un movimento si stabilisce tra il **cervello**, con la **cefalizzazione**, e il cuore, la **cardializzazione**, permettendo il loro incontro.

Nello stesso momento, i due tubi endocardici si incontrano sulla linea mediana. Segue il **looping** del cuore, poi la formazione del **sinusoide cardiaco** e dell'**arco aortico**, con i grandi vasi.

L'**asse cavo** serve da riferimento.

È importante osservare se il cuore si esprime su un piano sistolico o diastolico. Facialmente, cerca più la diastole o la sistole.

Rispetto all'iliaco, cerca molto di più l'**orizzontalità**, il che indica un movimento diastolico. Possiamo arrivare a cercare il **polso aortico**.

SVILUPPO CEREBRALE E CARDIACO

Integreremo progressivamente lo sviluppo del cervello rispetto al movimento di sviluppo.

Il primo movimento di sviluppo del cervello è stata l'**espansione**. Questa espansione dipendeva dall'**asse longitudinale** o dall'**asse mesenterico**. Dipende dall'integrazione vitellina, il cui vestigio si ritroverà sull'asse mesenterico.

Poi, un altro livello importante per la nutrizione è il sistema tra la **milza** e il **fegato**, con il ritorno al cuore tramite la **vena cava**. Poi, l'informazione aortica si manifesterà attraverso quattro o due porte d'ingresso: carotidea, sopra, sotto, vertebrale.

Integriamo così lo sviluppo del cervello con il cuore e il sistema mesenterico. Lavorando sul cervello, si osserva quale campo deve aprirsi. Si possono affinare le percezioni per determinare le zone da trattare, ad esempio sul sistema carotideo rispetto al cuore.

Questo può essere fatto dando semplici punti di appoggio, siano essi fulcri embrionali o punti di appoggio nella costruzione, per ridinamizzare la forza di rigenerazione.

Un fulcro è un punto di emergenza. Tutta la forza di sviluppo, come l'integrazione della **vescicola vitellina** in un'arteria (un vestigio della via di sviluppo e non un fulcro embrionale), si trova tra il fulcro e la finalità.

Iniziamo a percepire il gioco in cui ci impegneremo, perché lavoreremo su arterie specifiche. L'obiettivo è ridare la **piena omeostasi**, la piena vitalità, la piena salute.

ORIGINE DEL FULCRO E ONDA MESODERMICA

Toccherò l'origine del suo fulcro, che si ritrova in modo indiretto a livello coccigeo, poi si integrerà a poco a poco nel suo sistema attraverso il movimento di sviluppo del **manotococcus**, quest'onda con questa aspirazione a livello del mesoderma.

È un'informazione che ristruttura, ridinamizza, ridà forza al tessuto, ridà funzione.

Lo sviluppo delle forze embrionali permette lo sviluppo della funzione principale del sistema.

IL RUOLO CENTRALE DEL DIAFRAMMA

Il grande maestro per tutto questo sarà il **diaframma**. Si tratta di posizionarsi bene su questo diaframma con tre livelli:

- **Cavità amniotica** sul piano trasversale
- **Toracico**
- **Addominale**

Questa integrazione del celoma, e allo stesso tempo l'integrazione del cervello, del cuore, del diaframma, la parte posteriore del peritoneo, per tornare sul **perineo** e ridare, attraverso questa bascula del fegato, tutta la chiusura della mia linea alba, che darà tutta l'informazione **urogenitale**.

LA LINEA ALBA E IL SISTEMA UROGENITALE

È così che si formerà. La **linea alba** rappresenta l'integrazione completa del piano urogenitale, è la sua storia finale.

Su questa linea alba, potremo cercare concentrazioni di tempo cristallizzate, perché è una linea di probabilità in rapporto con l'**eritrocita**, la formazione dei globuli, quindi un futuro, dove il piano della **copula** è anche il tuo futuro.

Al momento dell'uscita, si verifica lo stiramento, ed è così che tutto il sistema genitale esterno e interno si integrerà su questo piano della linea alba anteriore. Essa termina per ricostruire.

Su un piano dei globuli, l'**eritrocitosi** o la **gonocitosi** avanzano. Ad un certo punto, l'embrione fa un movimento. C'è una linea di iniziazione nella vita. Al momento della nascita, bisogna aprire questa linea, la linea alba, e iniziare alla vita.

FULCRI EMBRIONALI E SISTEMA ARTERIOSO

L'idea sarà di ridare i giusti **fulcri embrionali**. Il sistema arterioso deve essere visto come un **polpo**.

Domani, dettagliamo il sistema arterioso a livello del viso, perché è una porta di accesso trofico a livello del cervello. Bisognerà comprendere lo sviluppo del sistema carotideo e del sistema vertebrale.

Questi due sistemi, con tutta l'informazione sul **poligono di Willis** e le **arterie cerebrali** anteriore, media, posteriore, così come i seni o le valvole (di Brechet o di Thierry Goïdienne, ecc.), sono spazi di equilibrio.

EQUILIBRIO VASCOLARE CEREBRALE

Abbiamo bisogno di un equilibrio tra l'apporto vascolare e il ritorno venoso. Ora sappiamo che esiste un **sistema linfatico** nel cervello.

Per eliminare i surplus, alcuni possono avere una **congestione linfatica** o venosa a livello del cervello. Lo si constata nelle persone un po' gonfie, un po' edematose. Il ritorno non avviene.

Un lavoro di riequilibrio sul piano venoso è quindi necessario, sia a livello della **vena cava superiore** che inferiore. Questo è importante per evitare le congestioni, in particolare a livello delle orecchie, e tutto ciò che non può essere evacuato.

POSTURA TERAPEUTICA

Mi posiziono bene a livello del coccige e del cuore. Si può visualizzare l'**angolo di Louis**, il tronco vascolare di tipo aortico polmonare.

Il cuore è sull'**asse longitudinale**. Solo una parte di esso è dilatata verso sinistra, con una fase di sviluppo sulla sua punta del cuore a sinistra.

Vi posizionerete sul piano longitudinale del cuore. Dando un fulcro qui e un punto di appoggio sul cuore, la mia attenzione è nello spazio, neutra, e lasciamo che il sistema si organizzi.